

Intervenciones breves y programas de rehabilitación

1. Introducción y relevancia clínica

El **trastorno por consumo de sustancias (TUS)** es una **enfermedad crónica, recurrente y prevenible**, con impacto sanitario, social y económico significativo.

En Chile, afecta aproximadamente al **10–15% de la población adulta**, siendo las sustancias más prevalentes el **alcohol, cannabis, benzodiacepinas y cocaína** (SENDA, 2023).

El manejo no se limita a la desintoxicación: requiere una **intervención integral, escalonada y continua**, que abarca **prevención, tratamiento y rehabilitación**.

Las **intervenciones breves y programas de rehabilitación** son las herramientas principales para la **reducción de daño, prevención de recaídas y reinserción social**.

- ❑ En el **EUNACOM**, los casos más comunes presentan pacientes detectados en APS o Urgencias con consumo problemático. Se evalúa la **capacidad del médico para reconocer el riesgo, aplicar una intervención breve y derivar adecuadamente**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Modelo biopsicosocial de la adicción

El consumo problemático se comprende como una **interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales**:

Dimensión	Factores asociados
Biológica	Vulnerabilidad genética, alteraciones dopaminérgicas, comorbilidad médica.
Psicológica	Impulsividad, ansiedad, trauma, baja autoestima, déficit de afrontamiento.

Social Desempleo, pobreza, redes de consumo, violencia, exclusión.

El abordaje terapéutico debe **intervenir en todos estos niveles**, promoviendo la autonomía y la capacidad de sostener la abstinencia.

2.2. Etapas del cambio (Prochaska y DiClemente)

Las intervenciones breves se apoyan en el modelo transteórico del cambio, que reconoce que el paciente avanza progresivamente en su disposición al cambio:

Etapas	Características	Intervención sugerida
Precontemplación	Niega el problema.	Educación empática, sin confrontación.
Contemplación	Reconoce el problema pero está ambivalente.	Explorar pros/contras, motivar reflexión.
Preparación	Dispuesto a cambiar.	Plan de acción y apoyo profesional.
Acción	Inicia el cambio (abstinencia o reducción).	Refuerzo positivo y seguimiento.
Mantenimiento	Mantiene abstinencia.	Prevención de recaídas, apoyo comunitario.
Recaída	Retoma consumo.	Reencuadrar sin juicio, reiniciar proceso.

☐ En atención primaria, el objetivo es **mover al paciente una etapa hacia adelante**, no lograr la abstinencia inmediata.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El enfoque clínico de este tema no se basa en síntomas patológicos, sino en **la detección del riesgo de consumo problemático** y la **motivación al cambio**.

3.1. Detección temprana

- Consumo frecuente o en grandes cantidades.
- Pérdida de control o uso en situaciones de riesgo.
- Problemas familiares, laborales o legales relacionados con el consumo.
- Antecedentes de tratamientos previos sin adherencia.

3.2. Herramientas de tamizaje

- **AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)**: evalúa consumo riesgoso de alcohol.
- **ASSIST (OMS)**: para múltiples drogas.
- **DAST-10**: detección rápida de abuso de drogas.
- **CAGE**: útil en atención primaria (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener).

☐ Un puntaje alto **no es diagnóstico de dependencia**, pero indica necesidad de **intervención breve o derivación**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes básicos

- Perfil hepático, renal y metabólico.
- Test toxicológico (orina, sangre o saliva).
- Función tiroidea y glicemia (descartar causas médicas de síntomas).
- Serologías (VIH, VHB, VHC en usuarios de drogas inyectables).

4.2. Diagnóstico clínico

El diagnóstico sigue los **criterios DSM-5 o CIE-10/CIE-11**, según la severidad del consumo y el impacto funcional.

El objetivo de la intervención breve **no es establecer diagnóstico formal**, sino **detectar riesgo y motivar el cambio**.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

1. **Intervención oportuna en todos los niveles asistenciales.**
 2. **Modelo integral, biopsicosocial y centrado en la persona.**
 3. **Continuidad asistencial:** desde la detección hasta la rehabilitación.
 4. **Enfoque de reducción de daño y derechos humanos.**
 5. **Coordinación intersectorial:** salud, educación, trabajo, justicia y comunidad.
-

5.2. Intervenciones breves en atención primaria

Definición:

Estrategias estructuradas, de corta duración (5–15 minutos), destinadas a **identificar consumo de riesgo y promover la reducción o abstinencia**.

Componentes principales (modelo FRAMES):

Elemento	Descripción
F – Feedback	Ofrecer retroalimentación sobre el consumo y sus riesgos.
R – Responsibility	Destacar la responsabilidad personal del cambio.

A – Advice	Brindar consejo médico claro y personalizado.
M – Menu	Proponer alternativas (reducir, dejar, buscar ayuda).
E – Empathy	Escucha activa, sin juicio moral.
S – Self-efficacy	Refuerzo de la autoeficacia: “usted puede lograrlo”.

Duración: 1 a 4 sesiones (individuales o grupales).

Contexto: APS, urgencias, hospitales generales.

☐ Está demostrado que **una sola intervención breve puede reducir significativamente el consumo de alcohol y otras drogas** a 6 meses (OMS, 2021).

5.3. Programas de rehabilitación

Chile dispone de una red de atención estructurada por niveles de complejidad:

a. Nivel 1: Atención Primaria (APS / COSAM)

- Detección y diagnóstico inicial.
- Intervención breve y seguimiento.
- Derivación a red SENDA o hospital.
- Psicoterapia ambulatoria de baja intensidad.

b. Nivel 2: Centros Especializados Ambulatorios (COSAM, SENDA)

- Tratamiento integral multidisciplinario.
- Psicoterapia individual y grupal (TCC, entrevista motivacional).
- Control médico y farmacoterapia (naltrexona, disulfiram, metadona, buprenorfina).
- Intervención familiar.

c. Nivel 3: Hospitalización o Comunidad Terapéutica

- Indicada en:
 - Dependencia grave o poliadicción.
 - Comorbilidad psiquiátrica severa.
 - Fracaso de tratamiento ambulatorio.
- Incluye fases de:
 - Desintoxicación supervisada.
 - Rehabilitación intensiva.
 - Reinserción sociolaboral.

□ **Ejemplos:** Hospital El Peral, Hospital del Salvador, Comunidad Terapéutica “Día a Día”, entre otros.

5.4. Componentes del tratamiento integral

Área	Intervención
Médica	Desintoxicación, farmacoterapia (metadona, buprenorfina, disulfiram, naltrexona).
Psicológica	TCC, entrevista motivacional, terapia de grupo, mindfulness.
Familiar	Psicoeducación, límites, apoyo emocional.
Social	Reinserción laboral, vivienda, acompañamiento comunitario.
Recaídas	Prevención mediante identificación de factores gatillantes y fortalecimiento de redes.

5.5. Prevención de recaídas

Basada en el modelo de Marlatt y Gordon:

- Identificar **situaciones de alto riesgo**.
- Aprender **estrategias de afrontamiento** (evitación, control cognitivo).
- **Reestructuración cognitiva**: no considerar la recaída como fracaso, sino parte del proceso.
- Refuerzo de **redes de apoyo** (familia, grupos, pares).

□ En EUNACOM, esto suele preguntarse como:

“¿Cuál es el siguiente paso tras una recaída?”

✓ Respuesta correcta: **Reevaluar motivación y reintegrar al proceso terapéutico**.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Recaídas múltiples (60–80% en el primer año).
- Comorbilidad psiquiátrica no tratada (depresión, ansiedad, trastorno bipolar).
- Exclusión social, desempleo, violencia.
- Riesgo de suicidio.

6.2. Pronóstico

- Mejor en pacientes con:
 - Alta motivación personal.
 - Apoyo familiar sólido.
 - Participación en programas estructurados ≥6 meses.
- Peor en:

- Policonsumo.
- Trastornos duales.
- Entornos desfavorables (violencia, pobreza).

□ Con un enfoque integral, el **70% de los pacientes logra reducción significativa o abstinencia mantenida.**

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas clínicas

1. La **intervención breve** es la herramienta más efectiva en APS para consumo riesgoso.
 2. **FRAMES** es el modelo operativo para intervención breve.
 3. **COSAM y SENDA** son los principales puntos de derivación en Chile.
 4. La **psicoeducación familiar** es crucial para mantener la abstinencia.
 5. Los **tratamientos prolongados (>6 meses)** mejoran el pronóstico.
 6. Las **recaídas son parte del proceso**, no un fracaso.
 7. Los **grupos de apoyo** (AA, NA) complementan la terapia profesional.
-

□

Errores comunes

- Esperar que el paciente “pida ayuda” para intervenir.
- Juzgar o confrontar de forma directa (“debes dejarlo o morirás”).
- No derivar a programas de rehabilitación tras la desintoxicación.

- No abordar comorbilidades psiquiátricas asociadas.
 - Creer que las recaídas invalidan el tratamiento.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **intervenciones breves** son estrategias cortas, estructuradas y eficaces para consumo de riesgo.
2. El modelo **FRAMES** orienta la comunicación empática y motivacional.
3. Los **programas de rehabilitación MINSAL/SENDA** ofrecen tratamiento integral y escalonado.
4. La **psicoterapia cognitivo-conductual y la entrevista motivacional** son pilares del manejo.
5. La **recaída** no es fracaso, sino parte del proceso de aprendizaje y cambio.
6. La **reinserción social y familiar** es clave para el éxito terapéutico.
7. La **coordinación intersectorial** (salud, educación, trabajo, justicia) potencia la recuperación integral.